بروتوكول بحث · دكتوراه في الصحة العامة (PH. D.)

تعزيز الاستجابة المشتركة بين القطاعات لمختلف الاحتياجات الاجتماعية واحتياجات الرعاية الصحية المتزامنة لدى كبار السن الذين يعيشون في منازلهم: الأنماط، ورسم خرائط الموارد، وتحليل الشبكات.



Eric Bernier، M. Sc. و LL.M.
eric.bernier.1@umontreal.ca · erjb-web.github.io
دكتوراه في الصحة العامة · النظم والمنظمات والسياسات الصحية · ESPUM، جامعة مونتريال

بإشراف مشترك من
الدكتورتين Nadia Sourial و Géraldine Layani

كيف تنظم الاستجابة المشتركة بين القطاعات للاحتياجات الاجتماعية واحتياجات الرعاية الصحية المتزامنة لمختلف أنماط كبار السن الذين يعيشون في منازلهم؟

O1
تحديد مختلف أنماط كبار السن الذين يعيشون في منازلهم ولديهم احتياجات اجتماعية واحتياجات رعاية صحية متزامنة قد تستلزم استجابة مشتركة بين القطاعات في الرعاية الأولية.

O2
رسم خرائط الموارد المحلية التي يمكن تعبئتها في الرعاية الأولية للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية واحتياجات الرعاية الصحية المتزامنة لمختلف أنماط كبار السن الذين يعيشون في منازلهم، وتوصيف التباينات المكانية في توافرها وتنوعها وتكاملها وإمكانية الوصول إليها.

O3
تحليل التشكيلات التنظيمية للشبكات المشتركة بين القطاعات في الرعاية الأولية المعبأة في المنطقة للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية واحتياجات الرعاية الصحية المتزامنة لمختلف أنماط كبار السن الذين يعيشون في منازلهم، بهدف توصيف آليات عملها.

01 السياق

CCSMTL: 8 أقاليم CLSC، و48,575 شخصًا في سن 65 عامًا فأكثر في 2026
ISQ, 2026

≈3,700
طلبات إلى 211 من أشخاص في سن 70 عامًا فأكثر، 2021-2026
211 Grand Montréal، 2026

691
احتياجات غير ملبّاة لدى من هم في سن 60 عامًا فأكثر (تحليل الحساسية)
211 Grand Montréal، 2026

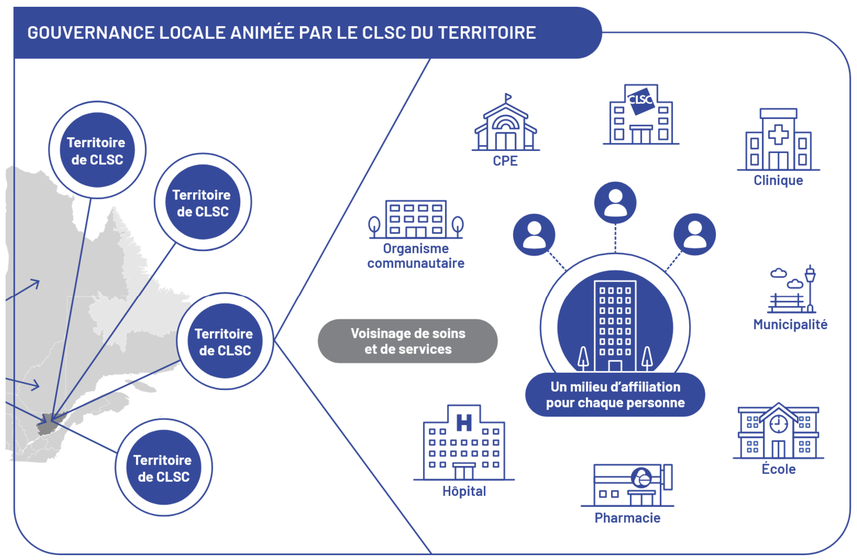
ثلاثة مفاهيم متمايزة
كبار سن يُناهَون في منازلهم تتراكم لديهم احتياجات اجتماعية؛ واستجابة تُنظَّم في إقليم CLSC.

احتياجات متزامنة
احتياجات اجتماعية ورعاية صحية موجودة لدى الأشخاص أنفسهم.

كبار السن الذين يعيشون في منازلهم
كبار السن في منازلهم ذوو احتياجات اجتماعية ورعاية صحية متزامنة قد تستلزم استجابة بين القطاعات في الرعاية الأولية.

تنظم داخل منطقة
استجابة مشتركة بين القطاعات
أعمال تقوم بها قطاعات غير الصحة، بالتعاون معها، بشأن الصحة أو محدداتها: الشبكة العامة، الخط الأول، القطاع شبه العام، المجتمع المحلي، البلدية، السكن.
MSSS, 2017 ; Leppo et al., 2013

سياسة الخط الأول · MSSS, 2026
منطقة CLSC تصبح الوحدة المرجعية



أدوار CLSC الأربعة
- ميسّر مشارك
- قائد مشترك بين القطاعات
- منسّق
- موجّه

«بروح من الحوكمة التشاركية» · MSSS, 2026, p. 42 · المخطط: MSSS, 2026

02 المنهجية المقترحة

بروتوكول مبدئي · المواقع والشراكات والتصاريح رهن التأكيد

كبار السن في منازلهم ذوو احتياجات اجتماعية ورعاية صحية متزامنة قد تستلزم استجابة بين القطاعات في الرعاية الأولية.

الهدف المنهجي O1
إجراء مراجعة للأدبيات العلمية لتحديد وتوصيف مختلف أنماط كبار السن الذين يعيشون في منازلهم ولديهم احتياجات اجتماعية واحتياجات رعاية صحية متزامنة قد تستلزم استجابة مشتركة بين القطاعات في الرعاية الأولية، وتحديد الاحتياجات المرتبطة بكل نمط من هذه الأنماط.

مراجعة نطاقية · 4 قواعد بيانات

- بحث منهجي ومعايير أهلية واضحة ومقيمان مستقلان.
- السكان وسياق الرعاية الأولية والاحتياجات الاجتماعية والصحية وتعريفاتها وأدواتها وتزامنها لدى الشخص نفسه والأنماط المنشورة.
- مراجعة نطاق وفق JBI وتقرير PRISMA-ScR؛ توليف وصفي للتعريفات والاحتياجات والتكوينات الموثقة.

الهدف المنهجي O2
إجراء دراسة خرائطية ومكانية للموارد القابلة للتعبئة في الرعاية الأولية للاستجابة لمختلف الاحتياجات الاجتماعية واحتياجات الرعاية الصحية المتزامنة المرتبطة بأنماط كبار السن الذين يعيشون في منازلهم بهدف توصيف توزيع هذه الموارد وتوافرها وتنوعها وتكاملها وإمكانية الوصول إليها مكانيا في مختلف مناطق CLSC.

6 قطاعات · تحليل بيني ومكاني

- تحديد منهجي للموارد المؤهلة مع قواعد صريحة للإدراج وإزالة التكرارات.
- الموقع والقطاع والاحتياجات والتوافر الموثق وشروط الوصول والأهلية والساعات والطاقة عند توفرها.
- دراسة خرائطية ومكانية في R وQGIS للتوزيع والتوافر والتنوع والتكامل وإمكانية الوصول المكانية.

الهدف المنهجي O3
إجراء تحليل استعادي للشبكات الاجتماعية بين القطاعات المعبأة في الرعاية الأولية انطلاقا من مناطق للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية واحتياجات الرعاية الصحية المتزامنة لمختلف أنماط كبار السن CLSC الذين يعيشون في منازلهم، لتوصيف تكوينها وبنية علاقاتها وطبيعة التعاون بين الفاعلين وشدته.

استبيان واحد · 12 شهرا · شبكات كاملة وشبكات الأنا

- استبيان علاقات واحد يطبق مرة واحدة عن الأشهر الاثني عشر الماضية؛ أسئلة مفتوحة مكملة دون مقابلات منفصلة..
- علاقات جميع المنظمات داخل حدود كل منطقة؛ التكوين والبنية والعمل بحسب التغطية المحققة.
- محيط المنظمات أو الفرق البؤرية ومنها CLSC؛ الحجم والتنوع وروابط الأنا بالآخرين. تتطلب الروابط بين الآخرين جمعا صريحا.

متباينة CLSC الشبكات. تحليل شبكات كمي رصدي استعادي في عدة مناطق O3 · الموارد O2 · الأنماط O1.

03 المخرجات المتوقعة · لا تعرض نتائج للأطروحة

أنماط مسندة بالأدلة وأمثلة توضيحية

أطلس ومصفوفة الاحتياجات والموارد والمناطق

شبكات موضوعة في سياقها وتفسير الآليات

فهم الفجوات بين الاحتياجات والعرض المتاح والمساعدة المستخدمة، ومناقشة خيارات التنظيم مع المعنيين والجهات المحلية. لا ضمان لفائدة فردية.

04 الإسهام المنشود

الاتصال ≠ التعاون ≠ تلقي المساعدة ≠ تلبية الحاجة. أرقام 211 وخرائط السياق أمثلة توضيحية، ولا تحل محل جمع بيانات O3.

Brewster, Tan, & Yuan (2019). Health Services Research, 54(6), 1246-1254. doi:10.1111/1475-6773.13206 · AHRQ (2014), Care Coordination Measures Atlas, ch. 4.